

Käitumisprobleemidega lapsed peaksid abi saama enne, kui asjad väga hulluks lähevad

Poliitikauuringute keskus Praxis uuris justiitsministeeriumi tellimusel tõsiste käitumisprobleemidega lastele ja noortele pakutavate teenuste olukorda. Praxise analüütik **Laura Aaben** ning kriminaalpoliitika uurijad **Jako Salla** ja **Anna Markina** rääkisid ajakirjale antud intervjuus asjast lähemalt.



JAKO SALLA, ANNA MARKINA JA LAURA AABEN
FOTO: LAUR RAUDSOO

Palun tutvustage ennast ja oma seotust uuringu teemaga.

Laura Aaben (L. A.): Noorte hälbiva käitumisega seotud uuringuid oleme koos teinud ka varem, viimati hindasime multidimensionalse pereteraapia (MDFT) programmi, nii et see töö oli loogiline jätk varasemale.

Jako Salla (J. S.): Justiitsministeeriumis töötades puutusin kokku noortele mõeldud teenuste, MDFT programmi rahastamise ja Eesti süsteemi sobitamisega. Olen analüüsinud ka õigusrikkumisi toime pannud alaealiste kohtlemist. Noorte õigusrikkumistele

reageerimine ja noortele mõeldud kinnised asutused on ühed mu lemmikteemad. Praegu juhin Sotsiaalkindustusmeti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonda.

Anna Markina (A. M.): Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teadurina olen uurinud alaealiste õigusrikkumisi ning viinud läbi intervjuusid lastega, et mõista probleeme ja seda, kus saaks sekkuda.

Mis oli uuringu taust ja eesmärk?

J. S.: Ministeeriumitel oli arusaam, et lapsed jõuavad vajalike teenusteni kas tervishoiu-

lastekaitse-, haridus- või karistussüsteemi kaudu. Eeldati, et laste taust, riskitegurid ja vajadused on üpris sarnased, kuid teenused sõltuvad sellest, milline valdkond nad esimesena n-ö kinni püüab. Uuring pidi näitama, millised on teiste riikide kogemusel noorte vajadused ning kust kasvab välja ja kuidas avaldub riskikäitumine: sõltuvusainete tarvitamine, enesevigastused või õigusrikkumised. Milline on kõige keerukam grupp ja milline sekkumine neid tulemuslikult aitaks. Tahtsime ka teada, kas noorte probleemide süvenemist on võimalik peatada ning äkki me hoopis soodustame seda midagi valesti tehes.

Millised noored olid uuringu sihtgrupp?

L. A.: Keskendusime tõsisesse raskustesse sattunud 13–18aastastele noortele, kelle puhul on suur risk, et probleemne käitumine võib jätkuda kogu ülejäänud elu. Paljud noored puuduvad koolist, proovivad uimasteid, panevad enne täiskasvanuks saamist toime õigusrikkumisi, kuid vaid väikesel osal neist jääb hälbiv käitumine püsima. Nad on korduvalt toime pannud isiku- või varavastaseid süütegusid, rikkumised on läinud järjest tõsisemaks. Ja nad kõik on jõudnud kas vanglasse või kinnisesse erikooli.

Mida te uuringu raames tegite?

J. S.: Koostasime ülevaate pakutavatest teenustest. Ja uurisime tagasiulatuvalt laste teekonda: mis süsteemidega ja kuidas nad olid kokku puutunud ja mis oli selle tulemus. Kui vanalt laps esimest korda alaealiste komisjoni jõudis, millal ja kui palju trahve sai, millal teda diagnoositi ja millised ravid määrati.

L. A.: Analüüsisime kaheksa noore juhtumeid. Nende kohta võtsime registritest välja teenuste kasutamise andmed.

Intervjueerisime last, tema vanemat ja spetsialiste, kes on juhtumiga töötanud. Noortelt küsisime tagasisidet, millise teenusega oli neil meeldiv kogemus ja kus ei olnud. Ka vanemad kirjeldasid, kust nad said abi ja kust mitte ning kuidas nad probleemidest aru saavad. Sageli pidid vanemad ise lapsele vajaliku teenuse otsima. Ekspertintervjuud tegime erikoolis, vanglas ja sotsiaalse rehabilitatsiooni osutajatega. Uuringuraportis avame laste lugusid põhjalikult. Kuigi neist ilmselt ei saa teha üldistusi kõigi laste kohta, on need väga näitlikud.

A. M.: Mõned juhtumid on tüüpilisemad, väga ekstreemsed lood aga töid ilmekalt välja süsteemi puudujärgid.

Kuidas avaldus uuringusse kaasatud lastel probleemne käitumine?

L. A.: Esimesed ilmingud olid neil juba algkoolis. Vaid ühe alaealise probleemne käitumine kujunes hiljem. Kirjandusest teame, et nii see tavaliselt ongi.

J. S.: Probleemid avalduvad juba 3–5aastaselt, kuid enamasti märgatakse hariduslikke erivajadusi ja õpiraskusi koolis. Laps pannakse ehk eriklassi, kuid mured kasvavad ja neile on väga keeruline ainult hariduslike meetmetega piiri panna.

L. A.: Sageli on käitumisprobleemid seotud psüühikahäiretega. Kõigil uurituil oli kas üks või mitu psühhiaatrilist diagnoosi, nad olid kokku puutunud ka psühhiaatriga, kuigi ei saanud seejärel ravi.

A. M.: Ebamugavat last hakatakse saatma ühe spetsialisti juurest teise juurde ja ühest koolist teise. Alles erikoolis saab ta ehk adekvaatset psühhiaatrilist abi. Samas oli juhus, kus isegi kinnises asutuses ootas laps mitu kuud psühhiaatri vastuvõttu.

L. A.: Hullema saaks ehk ära hoida, kui õige ravi ja tugiteenused oleksid tagatud algusest peale.

Kas vanemad oskavad probleeme märgata ja kas nad teevad koostööd?

L. A.: Probleemid, nt vägivaldne käitumine, avalduvad sageli ka kodus. On juhtumeid, kus vanem tahab lapsest loobuda ja teda erikooli panna, sest ta on ohtlik teistele lastele.

J. S.: Laps otsib aktsepteerimist nii oma perelt kui ka koolikaaslastelt. Kust ta seda ei leia, sealt tõmbub ta eemale. Kui ta tajub pidevat mittemõistmist ja rahulolematust, siis süveneb trots ning abi on väga raske vastu võtta. Sama kehtib ka vanemate puhul. Kindlasti saab seda muuta ja peret toetada, aga ei saa eeldada, et abi on suure rõõmuga vastu võetakse. Selle taga võivad olla näiteks varasemad negatiivsed kogemused spetsialistidega, häbitunne või käegalõimine ja lootusetus.

A. M.: Murede algfaasis kogevad vanemad sageli süüdistamist, et nad ei saa lapsega hakkama. See muudab suhted spetsialistidega halvaks ega soodusta koostööd. Kui vanemal tekib mõne psühhiaatri või lastekaitsetöötajaga usalduslik suhe, siis teeb ta meelsasti koostööd, ükskoik, millisel sotsiaalsel tasemel ta on.

Kas puudulikud vanemlikud oskused soodustavad probleemide kujunemist?

J. S.: Võib arvata, et lastel on mingid bioloogilised riskitegurid, tõsised psüühikahäired, milleks vanem ei peagi olema valmis. Ennekõike vajab sellises olukorras vanem abi ja toetust. Kuid ka praktiliste oskuste puudus on paljude probleemide taustal: sageli ei osata peres maandada konfliktset õhkkonda, või pole kindlat päevakava ja mõistlikku järelevalvet. Riske lisavad ka vanemate eluraskused.

L. A.: Oli ka peresid, kus ka õel või vennal on käitumisprobleem või on nad lausa vanglas. Siis pidi vanem tegelema juba mitme lapsega.

A. M.: Mõnikord tuleb enne lapse aitamist lahendada vanemate probleeme. Mõjub ka raske majanduslik olukord. Üks ema rääkis, et ta elab väga üle seda, mis tema lapsega toimub. Lubas, et noorema lapsega teeb ta kõik teistmoodi. Ja siis mainis, et see laps on viiepäevases lastehoius. Lihtsalt elu on selline. Ta peab tööl käima, sest kasvatab lapsi üksinda, ja tal on vahetustega töö.

L. A.: Perede lood on erinevad ja üldistada on raske. Oli ka üks hästi raske lugu, kus nooruk tappis inimese. Sel polnud sotsiaalsete probleemidega cellugu. Lapseni ei jõudnud abi, sest kohalikud tundsid vanemaid ega tahtnud seetõttu sotsiaaltöötaja juurde minna.

Mis olid uuringu olulisemad tulemused? Mis üllatas või pani mõtlema?

L. A.: Mind üllatas, et kõigil uuritud lastel on psühhiaatriline diagnoos. Ja kui palju on ravile haigekassa raha kulutanud: EMOs käimine, eneselõikumine, mürgistused, mitmekordne ja mitu nädalat kestev viibimine psühhiaatriahaiglas. Psüühikahäired vihjavad, miks neil asjad nii on läinud. Ka spetsialistid ei tule nendega alati toime, nad ei saa aru, miks asjad hoolimata jõupingutustest ei muutu. Psüühikahäire mõjutab käitumist ega tohi jääda tähelepanuta.

A. M.: Üks juhtum üllatas ka positiivselt. Laps oli osalenud Tallinna Turvakeskuse programmis „Jalad alla” ja see muutis tema elu. Ta rääkis, et on nüüd õppimise järele hull ja ta mõtleb karjäärile. Narkosõltuvuse tõttu otsustas ta õppida samas asutuses, kodus käis ta ainult magamas. Tema puhul tundus see toimivat.

L. A.: Häid kogemusi, kus asjad hakkasid paranema, oli ka Papaveris ja ka erikoolis. Kuid sageli on lapsed enne saanud mitmeid neile sobimatuid teenuseid. Mis tunne võib olla lapsel, keda niimoodi solgutatakse?

Ebapüsivust on hästi palju, kuidas lapse ellu saab nii stabiilsus tekkida?

J. S.: Uuringust tuli välja, et lapsed jõuavad erinevate spetsialistide juurde rohkem, kui esialgu arvasime. Eeldasime, et süsteemid on kui suletud „silotornid“, kuid reaalselt olid need keerukate probleemidega lapsed nähtavad nii lastekaitsele, õigussüsteemile, haridussüsteemile kui ka tervishoiule. See on iseenesest hea, kuid probleem on see, et iga süsteem toimetab omapäi. Me pole Eestis suutnud kujundada teenuseid sellest lähtudes, mida me noorte kohta teame. Teenustele suunamine ei ole süsteemne ega lähtu laste vajadustest.

L. A.: Ei olegi kohta, kuhu laps sobib, ja siis pannakse ta vägisi sinna, kus koht vabaneb. Näiteks normintellektiga tüdruk pandi intellektipuudega laste kooli, kuna see oli ainuke kinnine asutus, kus pakuti ka ravi.

J. S.: Praegune korraldus ei toeta seda, et muudaksime lapse kohtlemist lähtudes aastatega kogutud teadmistest. Kuhugi andmebaasi üles läinud teave ei jõua lastekaitsetöötajate, politsei, kriminaalhooldajate või erikooli spetsialistideni. Nt keerulise taustaga psüühikaprobleemidega lapsele kirjutab politsei ikka välja trahve või suunab ta ÜKTle. Läbimõtle mata mõjutusvahendid teevad asja hullemaks või ei mõjuta kuidagi, tekitades pigem ükskõiksust või trotsi.

A. M.: Lapsed enamasti isegi ei mäleta, kui palju on nad alaealiste komisjonis käinud. See on rutiin, mida nad ei võta tõsiselt. Mõni vanglas küsitletud laps kinnitas, et tundis kuni 14 aastaseks saamiseni, et talle ei tehta tema tegude eest midagi. Vangla tuli siis üllatusena, sest tingimisi karistustest ei teinud ta lihtsalt välja.

Millistest teenustest on puudus, mida tuleks muuta?

J. S.: Psühhiaatriline abi peaks sisalduma kõigis mitmekomponendilistes teenustes nii

haridus- sotsiaal- kui ka õigussüsteemis. See ei tähenda ainult vajalikke ravimeid, vaid ka vajaduspõhist teraapiat, ja eelkõige seda, et iga teenusepakkuja koosseisus oleks asjatundja, kes oskab tõlkida lapse häire kohtlemisvajaduseks. Praegu saab laps erikoolis mingi aja tagant kohtuda psühhiaatriga, kuid igas kinnises asutuses peaks personal oskama suhelda lastega viisil, mis pingeid maandab. See teeb võimalikuks nii ravi kui ka hariduse omandamise.

Ei olegi kohta, kuhu laps sobib, ja siis pannakse ta vägisi sinna, kus koht vabaneb.

L. A.: Praegused erikoolid, hooldekodud jm asutused ei paku ravi. Üks puuduv teenus ongi ravikodu ehk ravile orienteeritud kinnine asutus. Seal pakutakse koos teraapiat, hariduse omandamise võimalust ja tehakse ka peretööd. Lapsega tegeldakse intensiivselt, lähtudes tema erivajadusest.

Kes peaks teenuseid ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi looma?

L. A.: Teenuste väljatöötamine tõsiste käitumisprobleemidega lastele on Sotsiaalkindlustusameti ülesanne. Psühhiaatrilise abi kättesaadavus aga sõltub sellest, kui palju haigekassa seda kompenseerib ja kui palju on lastepsühhiaatreid.

A. M.: Teenused peavad olema peredele kättesaadavad. Üks Ida-Virumaa perekond käis lastepsühhiaatri juures Tartus. See on liiga kallis. Kohalik omavalitsus hakkas kulusid kompenseerima alles siis, kui laps sai diagnoosi ja puude.

Kirjutate uuringuraportis, et vaja on kesket juhtumikorraldust.

L. A.: Praegu on kokku leppimata, kust juhtumid algavad ja millal nad kellegi lauale jõuavad. Kui noor on toime pannud korduva süüteo, siis lähevad käiku ühed

asjad, ja seni, kuni pole toime pannud, teised asjad. Teenustele suunamise loogika on ebamäärane.

J. S.: Soovitame luua selgema süsteemi, mis kehtestab juhtumikorraldaja ülesanded ja kindlad vastusvaldkonnad. Juhtumikorraldajaks võib olla ka näiteks kriminaalhooldaja või kooli sotsiaalpedagoog, kui lapse abistamiseks piisab vaid ühe valdkonna piiresse jäävast sekkumisest. Oluline on, et spetsialistid saaksid kokku ja võrgustikutöö toimiks. Juhtumite puhul üllatas lastekaitsetöötaja väike roll nende keerukas olukorras laste eludes ja juhtumikorralduses. Ootame ju, et lastekaitsetöötaja vastutab lapse eest ka siis, kui laps on erikoolis või vanglas. Peaks olema nii, et ta käib last seal külastamas, temaga konsulteeritakse sekkumiste vajaduses ja tehakse koos ettevalmistusi, kui laps läheb asutusse või sealt vabaneb. Samas on need juhtumid aga nii keerukad riskide mõttes, et ka kriminaalhooldaja roll peaks olema palju suurem. Praegu korraldab ta valdavalt kohtu määratu täitmist, mitte lapse elu laiemalt.

A. M.: Juhtumikorraldus, kus arvestame lapse vajadustega ja leiame just talle sobiva lahenduse, on kooskõlas ka taastava õiguse põhimõtetega.

Kuidas saaks KOV lastekaitsetöötaja teie uuringu tulemusi kasutada?

J. S.: Kõige olulisem on juhtumikorraldaja. Alaealiste komisjone enam ei ole, abi korraldamine on lastekaitsetöötaja ülesanne, ta peaks olema kursis ka meditsiinilise, õigussüsteemi ja hariduse poolega. Ta peaks olema nagu liim erinevate spetsialiste ja asutuste vahel, kes tõmbab need asjad kokku.

L. A.: Ta ka hindab vajadusi või otsib kellegi, kes oskab hinnata. Uuringus kajastatud juhtumeist lugedes leiaks lastekaitsetöötaja ehk olukordi, millega saab samastuda, ja

tunneks ära märke, mis aitavad muresid ennetada. Aruande teoreetiline baas aitab aga mõista probleemide tausta. Ma ei tea, kas lastekaitsetöötaja saab vaadata terviseandmeid – laps ei pruugi ise oma diagnoosist rääkida. Kui käitumisel on meditsiinised põhjused, siis vajab laps erikohtlemist ja raviteenust.

See ei ole alati lastekaitse või kooli ebaõnnestumine, kui asjad ei edene. /.../ Lastelt ei tohi aga ära võtta võimalust, et asjad muutuksid paremaks.

A. M.: Lastekaitsetöötaja peab olema valmis reageerima, kui tema poole pöördutakse koolist või politseist. Ma ei tea, kas kõik spetsialistid jõuavad kõike juhtumikorraldajalt oodatut teha, eriti kui väikses vallas töötab lastekaitsja osalise ajaga ja tal on palju teisi ülesandeid.

J. S.: See ei ole alati lastekaitse või kooli ebaõnnestumine, kui asjad ei edene. Suur osa teismelisena aktiivset kriminaalset karjääri tegevatest noortest jätkab seda elu veel aastakümneid, aga ka see, kui suudame peatada rikkumiskäitumise 10–20 protsendi puhul on väga hea tulemus. See teadmine võtab ehk natuke pinget maha. Lastelt ei tohi aga ära võtta võimalust, et asjad muutuksid paremaks.

Kuidas hindate alaealiste olukorda vanglas?

A. M.: Lapsed on vanglas enamasti lühikest aega, alla aasta. Kui laps satub vanglasse jaanuaris, peab ta ootama septembrit, et kooli minna. Nad igavlevad ja mitte millegi tegemine muudab asjad hullemaks. Seda on vaja muuta.

L. A.: Üllatas, kui palju on vanglas nii-sama passimist. Riigi huvi peaks ju olema,

et noor ei jääski vangla vahet käima. Rakendada saaks intensiivseid sekkumisi ja struktureeritud päevakava.

J. S.: See on tohutu luksus, kui spetsialistidel on võimalik 24 tundi ööpäevas lapsega tegeleda. See käib nii vangla kui ka erikooli kohta. Asutused peaksid lapsele lähenema pindlikumalt ja individuaalselt.

A. M.: Praegu on vanglas 13 alaealist.

L. A.: Sellise raskusastmega lapsi, keda meie uuring puudutas, on Eestis kõige rohkem kokku paarisaja kandis. Neid ei ole nii palju, et asjakohaste teenuste loomine käiks üle jõu.

A. M.: Lastega peaks suhtlema iga päev ja loomulikult, mitte kord nädalas sotsiaaltöötaja kabinetis või sotsiaalprogrammi raames. Raportis jäi kajastamata, kuidas mõjutab resotsialiseerumist ja õppimist subkultuur. Kuni me seda ei muuda, ei ole vanglakaristus tõhus.

L. A.: Me ei näinud ühegi juhtumi puhul, et see oleks andnud häid tulemusi.

J. S.: Äkki annaks selle raha eest, mis kulub lapse vanglas hoidmiseks, pakkuda teenuseid väljaspool vanglat? Kui laps on endale ja teistele ohtlik, siis ei suudeta talle muid meetmeid paraku kiiresti pakkuda. Kui laps mitmendat ööd järjest vägivallatseb ja lõhub, siis vahistamine on justkui ainus asi, mida saab kohe rakendada. Teised meetmed jäävadki enamasti proovimata.

Noortekampade teemat arutanud töörühmas jäi kõlama mõte, et rohkem tuleks kaasata noortekeskusi. Kas sellest oleks kasu?

J. S.: Varase ennetuse etapis ja ajal, mil laste hälbivat käitumist võib põhjustada

sisustamata vaba aeg, on noortekeskustest, spordist ja huviringidest kindlasti kasu, aga meil on ilmselt veel palju arenguruumi selles osas, et hakkaksime just probleemse käitumisega noori tõrjumise asemel kaasa. Ma arvan, et neile ei peaks tegema eraldi pallimängurühmi või eraldi keskusi, peame suurendama olemasolevate inimeste ja asutuste oskusi ja võimekust väljakutsuva käitumisega toimetulemiseks ning tõrjumise asemel kaasamiseks.

A. M.: Teiste Euroopa riikide osas noortekeskustes on programme ka riskinoortele, kuid mitte nii keerulisele sihtrühmale, nagu käsitles meie uuring. Meie noortekeskustes selliseid programme pole. Võib-olla käiksid ka erivajadustega noored hea meelega noortekeskuses, kui neile seal midagi pakutaks.

Mis teemad vajaksid veel uurimist?

L. A.: Miks saavad venekeelsed lapsed oluliselt vähem hariduslikke tugiteenuseid – kas need ei kajastunud registrites või ei ole venekeelsetes koolides tugispetsialiste. Ja miks on vanglas venekeelseid lapsi rohkem.

A. M.: Kuivõrd mõjutab erikooli töö tulemuslikust see, et sinna satuvad ka vanglakogemusega lapsed ja kas personal on valmis nendega tegelema. Näiteks juhtum, kui erikoolis käiv laps paneb vaheajal toime kuriteo ja läheb selle eest vangi. Vabanemisel saadetakse ta tagasi erikooli, kuhu ta tuleb oma vanglas kujunenud tõekspidamistega.

J. S.: Analüüsida tuleks ka seda, milliseid teenuseid vajavad täisealiseks saanud noored. S

Küsitles Laur Raudsoo, pani kirja Regina Lind

„Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüsi” aruannet saab lugeda aadressil www.praxis.ee/tood/jum-uuring/.